1. בבת 65 נמצא Rheumatoid Factor (RF) חיובי בכייל גבוה. באנמנזה: סובלת למעלה מ- 10 שנים מ- Osteoarthritis (OA) עם נודולות הברדן במפרקים הדיסטליים באצבעות הידיים. בבדיקה אין סימנים למעורבות מפרקים אחרים. ספירת הדם, שקיעת דם ו- CRP תקינים, נוגדנים ל- CCP שליליים. מה נכון לגבי משמעות הבדיקות?

א. RF חיובי יכול להקדים הופעת RA במספר שנים
ב. RF חיובי נמצא ב- 20-25% מהאוכלוסייה הבריאה
ג. בדיקת נוגדנים ל- CCP היא בעלת רגישות גבוהה יותר מ- RF לאבחון RA
ד. RF חיובי לעומת נוגדנים ל- CCP, מנבא טוב יותר הסתמנות קשה של RA

2. מה הסיבה האפשרית ל- Peptic Ulcer Disease כשהבדיקה ל- *H. pylori* שלילית, ואין היסטוריה של שימוש ב- NSAID's?

א. Ulcerative colitis
ב. Celiac disease
ג. Whipple's disease
ד. Crohn's disease

3. בת 25, עם לימפאדנופתיה בבית השחי מימין, כשבוע לאחר שריטת חתול. בבדיקה: ללא חום או הגדלת קשריות בתחנות אחרות, בדיקת קרקעיות עיניים תקינה. מה יש להמליץ לחולה?

א. Doxycycline + Rifampin
ב. Erythromycin
ג. Trimethoprim/Sulfamethoxazole
ד. מעקב בלבד

4. מה רואים בתרשים האק"ג (**בתמונה 1**) של בן 45 שמועמד לניתוח אורטופדי?

א. היפרטרופיה של חדר ימין
ב. Left posterior fascicular block
ג. היפוך חיבורים (לידים) בין הזרועות
ד. Dextrocardia with situs inversus

5. בן 64, שאושפז בשל דלקת ריאות והלם ספטי, הונשם ומטופל באנטיביוטיקה, נוזלים ואמינים. במעבדה נמצא TSH 0.05 (תקין 0.5-4.1), FT4 10 (תקין 12-24) ו- FT3 2.1 (תקין 3.5-6.5). ידוע שתפקודי התריס מהקהילה לפני כחודשיים היו תקינים. מה מומלץ כעת?

א. מתן T4 לוריד עד לרמה של 15
ב. מתן T3 לוריד עד לרמה של 5
ג. מתן TSH לוריד עד לרמה של 2
ד. לא להתייחס לבדיקות התריס

6. מה הטיפול בחולה עם אנמיה ועם משטח הדם שמוצג **בתמונה 2**?

א. Plasmapheresis
ב. מתן ברזל
ג. מתן ויטמין B12
ד. מתן Prednisone

7. מה נכון לגבי זיהום ב- CMV בחולה מושתל כליה?

א. לרוב מופיע בחודש הראשון לאחר ההשתלה
ב. הדרך הטובה ביותר לאבחון היא תרבית דם ל- CMV
ג. CMV retinopathy מהווה ביטוי מוקדם יחסית של המחלה
ד. ניתן לטפל בזיהום פעיל של CMV ב- Valganciclovir פומי

8. איזו תרופה קבועה, שנוטלת בת 76, עלולה לגרום להפרעת הקצב **בתמונה 3**?

א. Omeprazole
ב. Brotizolam
ג. Verapamil
ד. Empagliflozin

9. מה נכון לגבי הטיפול בתסמונת דום נשימה בשינה (Obstructive Sleep Apnea)?

א. ניתוח בדרכי אוויר עליונות יעיל יותר מהשימוש ב- CPAP
ב. השימוש ב- CPAP הוכח כגורם לשיפור באיכות חיים
ג. שימוש בחמצן הוכח כיעיל בהפחתת תמותה
ד. אחוז ההיענות של מטופלים ל- CPAP נמוך מ- 30%

10. איזה מנגנון פעולה של תרופה **<u>יעיל יותר</u>** לטיפול ב- Rheumatoid arthritis?

א. עיכוב IL-17
ב. עיכוב הרצפטור ל- IL-1
ג. עיכוב IL-2
ד. עיכוב הרצפטור ל- IL-6

11. בן 55, שסובל מצרבות, בא לבקש מידע על Barrett's Esophagus. מה יש לומר לו?

א. הסיכון ל- Squamous carcinoma בושט גבוה מזה שבאוכלוסייה הכללית
ב. סיכון לסרטן ושט קיים רק בנוכחות גורמים נוספים (עישון והשמנת יתר)
ג. בנוכחות תסמיני רפלוקס כ- 10 שנים או יותר יש לשקול ביצוע גסטרוסקופיה
ד. לצורך האבחנה אפשר להסתפק בבליעת בריום במקום גסטרוסקופיה

12. אחות בבית חולים ננשכה ע"י מטופל המאושפז תקופה ארוכה. מה נכון לגבי פציעה זו?

א. אין הבדל בהרכב חיידקי הפה בין חולה מאושפז ואדם בריא
ב. נשיכת אדם גורמת לפחות זיהומים מנשיכת בעל חיים אחר
ג. **<u>לא</u>** מומלץ טיפול אנטיביוטי מניעתי בנשיכת אדם
ד. מומלץ טיפול אנטיביוטי למשך 10-14 יום במקרה של זיהום

13. בת 70, עם שוק ספטי (septic shock) לאחר ניקוי דגים. בבדיקת היד בצקת ונגעים נמקיים. בתרביות הדם צמיחה של מתגים (Bacilli) גרם-שלילים. מה מחלת הרקע **<u>השכיחה ביותר</u>** בחולים המופיעים עם תמונה זו?

א. ממאירות סולידית
ב. מחלת מעי דלקתית
ג. שחמת הכבד
ד. סוכרת

14. בן 62, בריא בד"כ. הובא למיון עקב כאבי ראש עזים וסחרחורת. שולל כאבים בחזה או קוצר נשימה ואינו נוטל תרופות קבועות. בבדיקה: בהכרה ומשתף פעולה, לחץ הדם 186/98 ממ"כ, דופק 56 לדקה, ריווי חמצן 98% באוויר החדר. תרשים אק"ג **בתמונה 4**. מה הצעד הבא שיש לעשות?

א. להתחיל ב- Aspirin ו- Clopidogrel
ב. להתקדם לצנתור כלילי בהקדם
ג. להתחיל ב- β-Blockers ו- Nitroglycerin לווריד

ד. להתקדם לבדיקת CT מוח דחופה

15. בן 63 התקבל בשל ST elevation MI, עבר צנתור עם פתיחת חסימה בעורק השמאלי הקדמי היורד. בבדיקת אקו לב אחרי הצנתור- מקטע פליטה של 35%. מה סביר למצוא בבדיקה הגופנית של החולה?

א. פיצול של הקול הראשון
ב. פיצול קבוע של הקול שני
ג. פיצול פרדוקסלי של הקול שני
ד. פיצול רחב של הקול שני

16. בן 42, בריא בד"כ, ללא מחלות רקע כלשהן, שבבדיקת CT בטן שבוצע בחשד לאבני כליה, מודגם באדרנל בשמאלי גוש בקוטר 3 ס"מ בעל צפיפות 2HU (Hounsfield Units). בירור הכולל כימיה, אלקטרוליטים, איסוף שתן לקורטיזול ולמטאנפרינים - נמצא תקין. מה יש להמליץ בשלב זה?

א. בדיקת רמת רנין ואלדוסטרון
ב. העמסת Saline 0.9%
ג. בדיקת רמת DHEAS
ד. אין צורך בבירור נוסף

17. בן 20, פונה לחדר מיון עקב צהבת ושתן דמי. בבדיקתו: חיוורון, דופק 120 סדיר. לחץ דם 110/70 ממ"כ, אין הגדלת קשריות למפה כבד או טחול. במעבדה: המוגלובין 5 גר'/ד"ל, MCV 103 עם 20% רטיקולוציטים, לויקוציטים ותרומבוציטים תקינים. בילירובין 3.9 מ"ג/ד"ל רובו בלתי ישיר. במשקע השתן אין ממצא. מה טיפול הבחירה בחולה זה?

א. מתן כדוריות דחוסות
ב. סטרואידים
ג. פלסמהפרזיס
ד. זריקות ויטמין B12

18. מה יגרום לפגיעה גלומרולרית **<u>בסבירות הגבוהה ביותר</u>**?

א. Cast nephropathy
ב. Tumor lysis syndrome
ג. Acute interstitial nephritis
ד. Hemolytic uremic syndrome

19. בן 58, עם ממאירות לבלב מפושטת וטיפול ב- Gemcitabine, Famotidine ו- Oxycodone. פונה בתלונות של ירידה בתפוקת השתן. שולל הקאות, שלשול או ירידה באכילה או בשתייה. במעבדה: עליית קריאטינין מ- 1 מ״ג/ד״ל (שבוע קודם לכן) ל- 4 מ״ג/ד״ל כעת. מה הסיבה **<u>הסבירה ביותר</u>** לאי ספיקת הכליות?

א. Acute interstitial nephritis על רקע התחלת טיפול ב- Famotidine
ב. Toxic acute tubular necrosis על רקע הטיפול ב- Gemcitabine
ג. Thrombotic microangiopathy על רקע הטיפול ב- Gemcitabine
ד. Acute interstitial nephritis על רקע טיפול כרוני ב- Oxycodone

20. מה נכון לגבי הטיפול ב- Tocilizumab?

א. תחליף לסטרואידים כקו ראשון ב- Giant cell arteritis
ב. לא גורם לאקטיבציה של שחפת
ג. דורש מעקב אחר רמות סוכר
ד. עלול לגרום לפרפורציה במערכת העיכול

21. בן 40 הסובל מאסתמה קשה ובלתי מאוזנת תחת טיפול בסטרואידים פומיים ובמשאפים, מתעניין באפשרויות טיפול נוספות. מה צריך לומר לו?

א. נוגדי IL-5 יכולים לסייע אם יש אאוזינופילים בכיח
ב. הוספת טיפול ב- Theophylline במינון גבוה היא אופציה מקובלת
ג. נוגדי TNF יכולים לסייע בטיפול
ד. טיפול ב- Omalizumab **<u>איננו</u>** מקובל

22. בן 30, פונה עם ארתריטיס סימטרית ומתלונן על שיעול דמי. בבדיקתו נגעים מורמים וכואבים על השוקיים, המודגמת **בתמונה 5**, ותרומבופלביטיס שטחי באזור פמורלי. מה עוד יימצא **<u>בסבירות הגבוהה ביותר</u>** בבדיקה הגופנית?

א. הגדלת כבד
ב. פריחת פרפר
ג. שיתוק העצב השביעי
ד. כיבים בפה

23. מה נכון לגבי בירור של גבר בן 60 עם אנמיה (המוגלובין 10 גר'/ד"ל), ששולל דמם ממערכת העיכול או ממקור אחר, כשבבדיקה יש דם סמוי חיובי בצואה?

א. ניתן להסתפק בקולונוסקופיה בלבד
ב. בהעדר סימפטומטולוגיה אין צורך בקולונוסקופיה
ג. אנגיוגרפיה של עורקי המעי היא בדיקת הבחירה במצבו
ד. גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה תקינות מחייבות בדיקת וידאו-קפסולה

24. בת 28, סובלת מאסתמה. בביופסיה מאנדוסקופיה, שבוצעה בשל אירועים חוזרים של Food Impaction בוושט, נראה ריבוי ניכר של אאוזינופילים. מה הטיפול המועדף בחולה?

א. טיפול משולש באנטיביוטיקה
ב. טיפול פומי ב- Budesonide
ג. טיפול פומי ב- Voriconazole
ד. טיפול במעכבי TNFα

25. בן 70, סובל מחום עד 38^0C, צריבה במתן שתן, וכאבים עזים באזור הפריאנאלי. בתרבית שתן צמיחה של *E. coli* ותרבית דם עקרה, תפקוד כלייתי תקין. מהו קו הטיפול הראשון כשהחיידק רגיש לכל תרופה?

א. Ceftriaxone
ב. Trimethoprim/Sulfamethoxazole
ג. Gentamicin
ד. Amoxycillin-Clavulanate

26. בת 28, מאובחנת כסובלת משחפת ריאתית. החיידק רגיש לכל התכשירים **חוץ** מ- Isoniazid. מה הגישה הטיפולית **הסבירה ביותר**?

א. טיפול בשלוש התרופות האחרות מקו ראשון למשך שישה חודשים
ב. טיפול בחמש תרופות, כולל קו שני, למשך 18-12 חודשים
ג. טיפול בארבע תרופות (כולל Quinolone) לשישה חודשים
ד. הוספת Linezolid לשלוש תרופות מקו ראשון וטיפול לשישה חודשים

27. מה ימצא **<u>בסבירות הגבוהה ביותר</u>** בבדיקה הגופנית של בן 70 עם צילום החזה **שבתמונה 6**?

א. פיצול של הקול הראשון
ב. איוושה בתחילת הדיאסטולה
ג. איוושה דיאסטולית מדרדרת לאחר קול פתיחה
ד. איוושה הולו-דיאסטולית

28. בת 69, ברקע יל"ד. הובאה לחדר המיון בשל הופעת שיתוק חדש בפלג הגוף הימני. איזו בדיקת CT **בתמונה 7**, מתאימה לחולה?

א.
ב.
ג.
ד.

29. באיזה מצב יש סיבה לקחת בדיקת Thyroglobulin?

א. בחשד ל- Hashimoto בחולה עם היסטוריה משפחתית
ב. בחולה ב- Graves מטופל ב- Methimazole
ג. בחשד ל- Thyroiditis תת חריפה
ד. בחולה לאחר Thyroidectomy וטיפול ביוד רדיואקטיבי

30. בן 75, מתלונן על חולשה. במעבדה: המוגלובין 9 גר'/ד"ל, תרומבוציטים 40,000, בממ"ק, לויקוציטים 1,200 בממ"ק עם נויטרופילים 500. משטח הדם **בתמונה 8**. מה אבחנת החולה?

א. לויקמיה מיאלואידית חריפה (AML)
ב. חסר בויטמין B12
ג. תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS)
ד. מיאלופיברוזיס (Myelofibrosis)

31. בן 68, סובל מאי ספיקת כליות חדה ומשמעותית אך עם תפוקת שתן מצוינת. מה האתיולוגיה **<u>הפחות סבירה</u>** לאי ספיקת כליות זו?

א. טיפול ב- Cisplatin
ב. טיפול ב- NSAID's
ג. טיפול ב- Amikacin

ד. טיפול ב- Amphotericin B

32. מה נכון לגבי טיפול ב- Sodium bicarbonate באי ספיקת כליות כרונית?

א. קיימת קונטרה אינדיקציה לטיפול זה לאור תכולת הנתרן הגבוהה
ב. יש לטפל כאשר ריכוז הביקרבונט יורד מתחת ל- 15 מא"ק/ליטר
ג. **אין** להתחיל טיפול זה בחולים הסובלים מהיפרקלצמיה
ד. טיפול זה יכול לעכב את ההתקדמות של אי ספיקת הכליות

33. בת 62, עם סוכרת ומטופלת ב- Empagliflozin, מתקבלת למיון בשל כאבי בטן והקאות. מה יתרום לאבחנה?

א. חישוב Anion gap
ב. בדיקת ריכוז גלוקוז
ג. בדיקת ריכוז אשלגן
ד. בדיקת INR

34. בת 28 מתלוננת על קוצר נשימה במאמץ שגובר בשנה האחרונה. היא אינה מעשנת וללא גורמי סיכון למחלת לב איסכמית. בבדיקת תפקודי הנשימה נתקבלו התוצאות הבאות: FEV1/FVC=0.8, FEV1=89%, FVC=95%, TLC=92%, RV=80%, DLCO=38%, (המספרים באחוזים הם percent predicted יחסית לאשה בגילה ובגובה של המטופלת). מה הצעד הבא שיש לעשות כעת כדי להתקדם באיבחון?

א. בדיקות סרולוגיות להפטיטיס
ב. בדיקת βHCG בשתן
ג. ביצוע צנתור כלילי
ד. ביצוע אקו לב

35. מה ההתבטאות הקלינית של מחלת משקעי קלציום-פירופוספט (CPPD)?

א. מעורבות המפרק המטוטרסאל-פלנגיאלי הראשון (MTP1) בדומה ל- Gout
ב. סינוביטיס סימטרית בדומה ל- Rheumatoid arthritis
ג. נודולות של פירופוספט מעל סחוסים וגידים בדומה ל- Gout
ד. מעורבות של החוליות בדומה ל- Ankylosing spondylitis

36. מה נכון לגבי הפקטורים הגנטיים בחולים ב- Celiac?

א. היארעות מחלה סימפטומטית גבוהה בשחורים ונמוכה בלבנים
ב. בכל החולים ימצא ביטוי של HLA-DQ2 או HLA-DQ8
ג. ל- >50% מהאוכלוסייה הכללית עם DQ2 או DQ8 יש Celiac
ד. המחלה מופיעה ב- >35% בבני המשפחה הגרעינית של החולים

37. מה נכון לגבי אפידמיולוגיה של מחלות מעי דלקתיות (IBD)?

א. עישון יכול להחמיר את המחלה ב- Ulcerative colitis
ב. כריתת תוספתן היא גורם מגן ב- Crohn's disease
ג. זיהום גסטרואינטסטינלי ב- *Shigella* ו- *Salmonella* מעלה סיכון ל- IBD
ד. שימוש בגלולות למניעת הריון קשור בהתפתחות Crohn's disease

38. מה נכון לגבי בדיקות הדמיה באבחון אנדוקרדיטיס?

א. בבדיקת TEE בשלב מוקדם יש False Negative של כ- 10%
ב. בדיקת הבחירה בחשד נמוך לאנדוקרדיטיס היא TEE
ג. בדיקת TTE מאבחנת היטב ווגטציות בגודל של 1 מ"מ
ד. PET-CT היא בדיקת הבחירה לזיהוי Native Valve Endocarditis

39. בן 80, אושפז בשל מחלת חום כשבמספר תרביות *Streptococcus gallolyticus*, רגיש ביותר לכל התכשירים האנטיביוטיים שנבדקו. באקו לב נמצאו וגטציות על המסתם המיטרלי. מה הטיפול בחולה?

א. Ceftriaxone למשך שבועיים
ב. Vancomycin למשך שבועיים
ג. Oxacillin למשך ארבעה שבועות
ד. Penicillin G למשך ארבעה שבועות

40. איזו הפרעה אלקטרוליטרית תסביר עליית מקטע ST בחיבורים V1-2 או ב- V3?

א. היפרקלצמיה
ב. היפרנתרמיה
ג. היפוקלמיה
ד. היפופוספטמיה

41. איזו תרופה ניתן להציע כטיפול בודד מיידי לחולה בת 50 עם VTE במצב המודינמי יציב וללא אי ספיקת לב ימנית?

א. Aspirin
ב. Warfarin
ג. Apixaban
ד. Dabigatran

42. איזו תרופה תעלה את יחס Aldosterone ל: Renin?

א. β-Blocker
ב. α-Blocker
ג. ACE-inhibitor
ד. Angiotensin Receptor Blocker

43. בן 83, נשלח לאשפוז בשל ירידה בתרומבוציטים ל- 50,000/ממ"ק. בספירות דם קודמות נראה שכבר שנים יש פנציטופניה קלה. משטח דם לא קידם באבחנה ובבדיקת מח עצם נמצאה היפרצלולריות, תהליך דיספלסטי בכל השורות ו- 10% בלסטים. בדיקת הכרומוזומים תקינה. מה הטיפול הנכון במחלתו?

א. Adriamycin
ב. Cytarabine
ג. Azacitidine
ד. Lenalidomide

44. בן 62, סובל מיתר לחץ דם, סוכרת, מחלת לב איסכמית ואי ספיקת כליות דרגה IV. איזו תרופה עלולה לגרום בסבירות הגבוהה ביותר לחוסר איזון בלחץ הדם?

א. Epoetin alfa
ב. Ticagrelor
ג. Linaglipin
ד. Liraglutide

45. איזו תרופה נותנת את ההגנה הטובה יותר כנגד אירועים מוחיים?

א. Amlodipine
ב. Ramipril
ג. Atenolol
ד. Doxazosin

46. מה ידוע על תופעות הלוואי של תרופות להורדת ריכוז חומצה אורית (UA)?

א. בחולים אלרגיים ל- Penicillin יש שכיחות יתר לתופעות טוקסיות של Allopurinol
ב. תופעות הלוואי המסוכנות ביותר הן קרדיאליות
ג. תופעת לוואי חשובה של Febuxostat היא Granulomatous hepatitis
ד. Allopurinol עלול לגרום ללויקוציטוזיס

47. בת 28, בריאה בד"כ, מעשנת כ- 10 סיגריות ליום ונוטלת גלולות למניעת הריון, פונה למיון עקב קוצר נשימה וכאבים בחזה ימין שהחלו בטיסה חזרה מלוס אנג'לס. בבדיקתה: חום 37, דופק 128 סדיר, לחץ דם 80/40 ממ"כ, 30 נשימות לדקה סטורציה 92% עם חמצן במסיכה. צילום החזה **בתמונה 9**. מה הצעד הבא?

א. מתן tPA 100 מ"ג במשך שעתיים
ב. בדיקת אקו לב
ג. בדיקת CTA ריאות
ד. ניקוז עם מחט

48. בת 35 פונה בשל חולשה, ירידה במשקל ונשירת שיער. בבדיקתה אפטות בפה. במעבדה: כימיה תקינה, בספירת דם 3,400 לויקוציטים/ממ"ק (1,500 נויטרופילים), שתן ללא ממצא. ANA חיובי והומוגני בטיטר 1:320, בדיקת anti-double stranded DNA חיובית בטיטר מעט מוגבר, רמת C3 נמוכה ורמת C4 תקינה. מה הטיפול המומלץ בשלב זה?

א. Methotrexate פעם בשבוע ולאחר מכן חומצה פולית
ב. Prednisone 10 mg בכל בוקר לאחר האוכל
ג. Hydroxychloroquine פעמיים ביום
ד. SC Belimumab פעם בכל שבוע

49. בן 68, עם Crohn's disease, מטופל בסטרואידים וב- Azathioprine, ונשקלת החלפת הטיפול ל- Anti-TNF. מה נכון לגבי הסיכון של חולה זה לחלות ב- Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL)?

א. מחלתו הבסיסית **לא** נמצאת באסוציאציה להתפתחות NHL
ב. הטיפול בסטרואידים מעלה סיכון ל- NHL
ג. הטיפול הכרוני ב- Azathioprine מעלה את הסיכון ל- NHL
ד. טיפול ב- Anti-TNF מעלה את הסיכון ל- NHL יותר מ- Azathioprine

50. מתי יש לבצע בדיקת סקר אנדוסקופית לסרטן המעי הגס בחולים עם מחלות מעי דלקתיות?

	מתי לבצע את בדיקת הסקר	**איבחון המחלה הבסיסית**	**מחלה בסיסית**
א	כל 3-4 שנים	לפני 5 שנים	Crohn's disease
ב	כל 3-4 שנים	לפני 2 שנים	Ulcerative pancolitis
ג	כל 5 שנים	לפני 2 שנים	Crohn's colitis
ד	כל 1-2 שנים	לפני 15 שנים	Left-sided Ulcerative colitis

51. בת 70 עם קוצב לב מתקבלת עקב חום וצמרמורת. בתרביות הדם צמיחה של Methicillin Resistant *Staphylococcus Aureus* (MRSA) במספר בקבוקים. בהנחה שאין מקור ברור לבקטרמיה, מה הגישה הטיפולית המועדפת בחולה?

א. יש להוציא את הקוצב והאלקטרודות בהקדם ולטפל כמומלץ באנדוקרדיטיס
ב. יש להוציא את הקוצב והאלקטרודות בהקדם ולטפל אנטיביוטית עוד שבועיים
ג. יש לתת טיפול אנטיביוטי מתאים למשך 14 יום
ד. יש לטפל אנטיביוטית ולהוציא את הקוצב והאלקטרודות כשתרביות הדם שליליות

52. בן 65, ברקע החלפת מסתם מיטראלי, מאושפז כעת בשל אנדוקרדיטיס וצמיחה של *Streptococcus anginosus* בדם. למרות טיפול ב- Penicillin לפי רגישות ו-MIC מתאימים, עדיין חום לאחר מספר ימים. האק"ג מוצג **בתמונה 10**. מה יש לעשות כעת?

א. להמשיך טיפול במינון גבוה יותר של Penicillin
ב. להכין את החולה לניתוח ולהמשיך באותו טיפול
ג. להחליף את הטיפול ל- Ceftriaxone במינון גבוה
ד. יש להוסיף לטיפול האנטיביוטי גם Rifampin

53. בן 42, מתלונן על שיעול מזה כמה חודשים. בבדיקה: אקספיריום מאורך וחירחורים אינספירטורים גסים מפוזרים. צילום החזה **בתמונה 11**. באיזו צורה תתבטא השפעת מחלתו על תרשים האק"ג?

א. QT מוארך
ב. AV block
ג. עליות ST בחיבורי החזה
ד. Q1S3T3

54. מה יש לתת לחולה לפני ניתוח לכריתת Pheochromocytoma?

א. IV Dextrose
ב. IV Saline
ג. PO Propranolol
ד. SL Nitroglycerine

55. בן 65, עם ירידת 10 ק"ג במשקל בחצי שנה אחרונה ושובע מוקדם. בבדיקה: חיוור, טחול 8 ס"מ מתחת לקשת הצלעות. במעבדה: המוגלובין 8 גר'/ד"ל, טסיות 25,000/ממ"ק ולויקוציטים 15,000/ממ"ק. המשטח **בתמונה 12**. מה האבחנה?

א. מיאלופיברוזיס
ב. לויקמיה מיאלואידית חריפה
ג. תסמונת מיאלודיספלסטית
ד. אנמיה המוליטית אוטואימונית

56. בן 38, שבגלל השמנת יתר עבר ניתוח בריאטרי לפני 6 חודשים, מתקבל למיון בעקבות קוצר נשימה במאמצים ללא כאבים בחזה. בבדיקה: לחץ דם 140/90 ממ"כ, דופק 120 לדקה, סטורציה 90% באוויר החדר, ללא חום. בצילום חזה צל לב מוגדל עם גודש בשערים. באק"ג - סינוס טכיקרדיה, ללא סימני איסכמיה. מתן של איזה מהבאים יטפל בבעייתו הבסיסית של החולה?

א. IV Iron
ב. Methimazole
ג. Adenosine
ד. Thiamine

57. חולה הסובל ממחלת Paget's ומטופל באופן קבוע ע"י IV Pamidronate פונה לרופא המטפל בשל עליה במשקל והתפתחות בצקות ברגליים. בשתן פרוטאינוריה ++++. מה יימצא בביופסיית הכליה ומה הטיפול בו?

	אבחנה בביופסיה כלייתית	טיפול
א	Membranous Nephropathy	הפסקת Pamidronate ומתן High-dose Steroids
ב	Membranous Nephropathy	הפסקת Pamidronate
ג	Focal segmental glomerulosclerosis	הפסקת Pamidronate
ד	Focal segmental glomerulosclerosis	הפסקת Pamidronate ומתן High-dose Steroids

58. מה עלול לגרום לשילוב של היפרקלמיה ויתר לחץ דם?

א. שימוש ב- NSAIDS
ב. שימוש ב- Non-selective β-Blockers
ג. Pseudo-hypoaldosteronism type I
ד. RTA type II

59. איזו תרופה מהווה גורם סיכון לארתריטיס הנגרמת משקיעת גבישי קלציום-אוקסלט בחולים המטופלים בדיאליזה?

א. Vitamin D
ב. Sevelamer
ג. Vitamin C
ד. Erythropoietin

60. בן 68 ללא רקע של עישון בכלל, מתלונן על קוצר נשימה בשנה האחרונה, שמופיע במאמץ ובשעות הערב והלילה, ולעתים מעיר משינה. בהאזנה לריאות צפצופים. בספירומטריה : יחס FEV1/FVC =0.59, FEV1=2.0 ליטר (77%), FVC=3.36 ליטר (97%). לאחר מתן מרחיבי סמפונות יחס FEV1/FVC = 0.86, FEV1 = 2.29 ליטר (88%), FVC=3.48 ליטר (100%) - האחוזים בסוגריים הם אחוז מהצפוי percent predicted. מה האבחנה הסבירה?

א. Bronchial asthma
ב. COPD
ג. Cardiac asthma
ד. Idiopathic Pulmonary Fibrosis

61. בת 28 שבעברה 3 הפלות בטרימסטר ראשון, מבצעת בירור שבו נמצאים נוגדנים ל- cardiolipin IgG ו- β2 glycoprotein IgG בכייל גבוה, בבדיקות חוזרות ובהפרש זמן של 16 שבועות. בירור ל- SLE שלילי. מה הטיפול המומלץ על מנת למנוע הפלה נוספת?

א. Aspirin
ב. Aspirin + LMWH
ג. Warfarin
ד. Rivaroxaban

62. סטודנטית בת 23, מתלוננת על שלשול במרקם רך ללא דמם כ- 4 פעמים ביום, וכאב בטן מזה כחצי שנה, שמשתפר לאחר פעולת המעיים ומוחמר בתקופת מבחנים. בדיקות דם שכללו ספירה, כימיה, תפקודי תריס, כבד וכליות וסרולוגיה לצליאק - תקינות. קלפרוטקטין בצואה תקין ותרביות צואה ופרזיטים שליליות. קולונוסקופיה עם איליוסקופיה תקינה. מה ניתן להציע לחולה?

א. טיפול ב- Ciprofloxacin
ב. טיפול ב- Metronidazole
ג. טיפול ב- Rifaximin
ד. טיפול ב- Fidaxomicin

63. בת 70, אושפזה עקב כאב בטן ימנית עליונה. בבדיקתה לחץ הדם 140/85 ממ"כ, דופק 95 לדקה, חום 38.5, צהבת בעור ובלחמיות ורגישות ברביע ימני עליון. במעבדה: לויקוציטוזיס 12,000 בממ"ק, בילירובין 3.5, ALP 800 ו- γGT 990. באולטראסאונד בטן נמצאו אבנים בכיס מרה. מה הטיפול הראשוני בה?

א. ביצוע ERCP דחוף
ב. טיפול אנטיביוטי והזמנת Endoscopic Ultrasound דחוף
ג. טיפול בנוזלים ואנטיביוטיקה כנגד חיידקי מעיים
ד. הכנסת נקז Percutaneous Transhepatic Catheter

64. מה עלול להיגרם ע"י נגיפים במושתלי מח עצם?

	נגיף	מחלה
א	EBV	B-cell Lymphoma
ב	CMV	Kaposi's sarcoma
ג	HSV-1	Ulcerative colitis
ד	VZV	Lymphadenopathy

65. בן 40, נשא HIV, לא מטופל, CD4 אחרון 27, מתקבל למיון בגלל בלבול, הקאה חוזרת וקשיון עורף. במשטח ישיר מהניקור המותני יש פטריות שמר. מה הטיפול בשלב זה?

א. Caspofungin
ב. Fluconazole
ג. Amphotericin B
ד. Voriconazole

66. מה ההשוואה בין Fondaparinux ל- Enoxaparin בטיפול לתסמונת כלילית חריפה ללא עליות ST?

א. יעילות דומה ל- Enoxaparin אך גורם פחות לדימומים מאג'ורים
ב. יעילות טובה מ- Enoxaparin אך עם עליה בשיעור הדימומים המאג'ורים
ג. יעילות פחותה מ- Enoxaparin אך עם פחות דימומים מאג'ורים
ד. יעילות טובה מ- Enoxaparin עם ירידה בשיעור הדימומים המאג'ורים

67. בת 22, מובאת למיון לאחר שנמצאה בהכרה מעורפלת ולידה אריזות ריקות של Amitriptyline, Paracetamol, Lorazepam. בבדיקה: ישנונית, לחץ דם 110/50 ממ"כ, דופק 100 לדקה, סטורציה שמורה. תרשים האק"ג **בתמונה 13**. מה הטיפול הראשוני בחולה?

א. Electrical shock
ב. Sodium Bicarbonate
ג. Calcium Gluconate
ד. Amiodarone

68. מה נכון לגבי היקף מותניים?

א. נמדד בגובה הטבור
ב. הערך התקין בגברים הוא עד 100 ס"מ
ג. הערך התקין בנשים גבוה מזה שבגברים
ד. משקף מסת שומן ויסצרלי

69. בן 70, עם CLL מזה 3 שנים. מגיע לבדיקה שגרתית לאחר אשפוז שלישי עקב דלקת ראות. בבדיקתו הגדלת קשריות לימפה צואריות ובבתי שחי עד 3 ס"מ, הטחול לא נמוש. במעבדה: המוגלובין 13.2 גר'/ד"ל, לויקוציטים 40,000 בממ"ק מתוכם 92% לימפוציטים, תרומבוציטים 129,000 בממ"ק. מה צריך לשקול להציע לחולה זה כעת?

א. Immnoglobulins
ב. G-CSF
ג. Ibrutinib
ד. מישלב של Fludarabine, Cyclophosphamide, Rituximab

70. מה נכון לגבי Diabetic nephropathy?

א. כ- 20% מחולי סוכרת סוג 2 ואי ספיקת כליות כרונית לא מפתחים אלבומינוריה
ב. העדר רטינופטיה בחולה עם סוכרת סוג 2 שולל מעל ל- 90% את הסיכוי לנפרופטיה
ג. המעקב לצורך גילוי נפרופטיה סוכרתית הוא בדיקת "סטיק" שתן אחת לשנה
ד. לרוב, הפרוטאינוריה בחולי סוכרת **לא** עולה על 1 -2 גר' ליממה

71. בן 86, ברקע מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, סוכרת ויתר לחץ דם. אושפז בשל פרפור עליות סימפטומטי חדש וטופל ע"י העלאת מינון חסמי ביתא, הוספת טיפול בדיגוקסין ואנטיקואגולציה. כשלושה שבועות לאחר מכן פנה בשל TIA ובבדיקת דם: עליית קריאטינין מ- 1 ל- 2.5 מ"ג/ד"ל ואאוזינופיליה קלה. בבדיקת שתן נמצאו פרוטאינוריה והמטוריה קלות. מה יש לעשות כעת?

א. להפסיק את הטיפול ב- Digitalis
ב. להפסיק את הטיפול האנטיקואגולנטי
ג. להפסיק את הטיפול ב- β-Blockers
ד. להפסיק את כל הטיפול התרופתי החדש ולהתחיל בסטירואידים

72. בת 54 התחילה טיפול בארתריטיס עם Methotrexate ופונה עקב חום וכיבים בפה. בספירת הדם פנציטופניה. מה הטיפול במצבה?

א. G-CSF
ב. IV Acyclovir
ג. Leucovorin
ד. N-acetyl cysteine

73. בן 77 סובל מאירועים חוזרים של שיעול עם כיח מוגלתי שלעתים קרובות מטופל באנטיביוטיקה בקהילה. כעת מתקבל עם אנמנזה של החמרה בשיעול הכרוני, חום 38.3 וכיח מוגלתי בצבע צהוב. מצורפת בדיקת ריאות, **תמונה 14**. איזו בדיקת עזר תסייע בביסוס אבחנתו?

א. רמת כלור נמוכה בזיעה
ב. רמת אימונוגלובולינים נמוכה בדם
ג. C-ANCA חיובי בסרום
ד. רמת שומן נמוכה בצואה

74. מה הטיפול המיידי המועדף בהתקף Gout חד של מפרק הברך בבן 80 עם אי ספיקת כליות (קריאטינין 2.5 מ"ג/ד"ל)?

א. Anakinra 100 x 1
ב. Colchicine 0.5 mg every 2 hours
ג. Prednisone 30 mg x 1
ד. Allopurinol 300 mg x 1

75. בן 50, ידוע על הפטיטיס C מגיל 20, מגיע למיון עקב הקאות דמיות ביממה אחרונה. בבדיקתו יש מיימת ובמעבדה המוגלובין 10 גר׳/ד״ל. בגסטרוסקופיה יש שלוש דליות גדולות. מה נכון לגבי הטיפול בדליות?

א. קשירת דליות היא טיפול הבחירה ברוב המקרים של דמם פעיל
ב. מתן Octreotide באופן סיסטמי ימנע את הצורך באנדוסקופיה לקשירת דליות
ג. קשירת דליות היא טיפול הבחירה לדליות גדולות מדממות בפונדוס הקיבה
ד. קשירת הדליות בזמן הדמם תמנע את הצורך בקשירות נוספות בהמשך

76. מה הנכון לגבי טיפול משתן (דיורטי) במיימת על רקע שחמת הכבד?

א. מועיל רק בשילוב עם ACE inhibitors
ב. יש להתחיל טיפול ב- Furosemide לפני התחלת טיפול ב- Spironolactone
ג. יש להימנע מטיפול משתן אם לחולה יש גם אי ספיקת כליות כרונית
ד. ניתן להגיע למינון ה- Spironolactone ל- 400-600 מ״ג ליממה

77. במי מהמטופלים עם HIV יש לטפל בתרופות אנטי-רטרווירליות?

א. במטופלים עם CD4<200
ב. במטופלים עם CD4<350
ג. במטופלות בהריון עם CD4<500
ד. בכל המטופלים ללא קשר למספר CD4

78. מה ההתבטאות הקלינית של וירוס Epstein-Barr בנשאי HIV?

א. Polyarthritis
ב. Oral Hairy Leukoplakia
ג. Pemphygus
ד. Auto-immune Parotitis

79. בן 70, מאושפז עקב דלקת באונה התחתונה של הריאה השמאלית ומטופל ב- Ceftriaxone ו- Azithromycin. ביום השני לאשפוזו החולה מאבד הכרה ומתאושש ספונטנית. במוניטור נראה הסטריפ **שבתמונה 15**. מה הצעד **<u>הנכון ביותר</u>** לעשות כעת?

א. הפסקת טיפול ב- Ceftriaxone
ב. מתן Amiodarone
ג. השתלת קוצב
ד. הפסקת טיפול ב- Azithromycin

80. בת 68, פונה בשל קוצר נשימה פרוגרסיבי כשברקע יל"ד. בבדיקה: השמנת יתר, לחץ הדם 170/90 מ"מ כספית, גודש ורידי צווארי ניכר ובצקות היקפיות. בתרשים אק"ג: מקצב סינוס והיפרטרופיה של חדר שמאל. בצילום חזה גודש ריאתי אינטרסטיציאלי עם נוזל פלוירלי דו"צ בכמות קטנה. באקו לב: מקטע פליטה של 65%. מתן איזו תרופה עשוי למנוע אישפוזים חוזרים?

א. Candesartan
ב. Metoprolol
ג. Verapamil
ד. Digitalis

81. לאיזה מטופל יומלץ על ניתוח בריאטרי להורדה במשקל?

	גיל	**מחלות רקע**	**BMI**
א	38	סוכרת	31
ב	50	סוכרת	36
ג	60	ללא מחלות רקע	36
ד	40	סוכרת ויתר לחץ דם	33

82. בת 66, אובחנה לפני 7 שנים כסובלת מלימפומה פוליקולרית וטופלה בכמותרפיה עם התייצבות המחלה. בשנה האחרונה יש הגדלה הדרגתית של קשריות לימפה, ובחודש האחרון הזעות ליליות, חום והגדלה מהירה של קשרית לימפה אקסילרית עד 5 ס"מ. בדיקות המעבדה תקינות מלבד LDH 3,220. מה צריך להציע לחולה כעת?

א. טיפול קרינתי לקשר במפשעה
ב. ביופסיה של הקשר האקסילרי
ג. טיפול כימותרפי יחד עם Rituximab
ד. השתלת מח עצם

83. בת 68, ברקע סקלרודרמה, מובאת למלר"ד מבולבלת. בבדיקה: לחץ דם 220/120 ממ"כ, דופק 68, סטורציה 97% באויר חדר, מתמצאת חלקית במקום ובזמן אך ישנונית. במעבדה: Hb 9.5 גר'/ד"ל, PLT 80,000 בממ"ק, WBC 8,000 בממ"ק, קריאטינין 2.8 מ"ג/ד"ל (לפני חודש - 1 מ"ג/ד"ל), אשלגן 4.2 מא"ק/ליטר, נתרן 140 מא"ק/ליטר. מה הטיפול בה כעת?

א. טיפול במעכבי ACE
ב. הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל- 180 ממ"כ תוך 24 שעות
ג. טיפול ב- Plasmapheresis
ד. טיפול בדיאליזה דחופה

84. חולה עם ממאירות קיבה החל טיפול ב- TPN. בנוסף ידוע על יתר לחץ דם המטופל ב- Thiazide. פונה בשל הקאות בלתי פוסקות וחולשת שרירים קשה. בבדיקתו, במצב כללי סביר, לחץ דם 120/80 ממ"כ, דופק 85 לדקה ללא סימני דה-הידרציה. במעבדה: קריאטינין - 1.2 מ"ג/ד"ל, אשלגן 2.8 מא"ק/ליטר. בשתן ריכוז אשלגן 24 מא"ק/ליטר וריכוז קריאטנין 200 מ"ג/ד"ל. מה הסיבה **הסבירה ביותר** להתפתחות היפוקלמיה בחולה זה?

א. ההקאות
ב. הטיפול ב- TPN
ג. הטיפול ב- Thiazide
ד. פסאודו-היפוקלמיה

85. בן 78, מטופל בהמודיאליזה מזה 10 שנים, פונה אלייך בשל נגע עורי שהתפתח על קיר הבטן, **תמונה 16**. איזו תרופה קבועה, אותה נוטל, יש להפסיק באופן מיידי?

א. Lanthanum carbonate
ב. Cinacalcet
ג. Paricalcitol
ד. Warfarin

86. בן 79 עם רקע של עישון עד לאחרונה (50 שנות קופסא) ואשפוז מדי שנה עם החמרה בקוצר הנשימה הכרוני והחמרת שיעול. כעת מגיע למרפאה לביקורת לאחר אשפוז ומביא תוצאות ספירומטריה, **תמונה 17**. מה ניתן לומר לו על סמך התוצאות?

א. למטופל יש COPD ורצוי לטפל במרחיבי סמפונות ארוכי טווח LABA, LAMA
ב. למטופל יש COPD עם העדר תגובה ולכן **אין** מקום לטיפול ב- LABA או LAMA
ג. למטופל יש אסטמה ויש לטפל בסטרואידים בשאיפה
ד. בהעדר נפחי ריאה לא ניתן לקבוע האם יש הפרעה חסימתית או רסטריקטיבית

87. בן 30 סובל מהפרשות דמיות והתכייבות במחיצת האף, ללא מעורבות עורית או ריאתית. בביופסיה מהאף נמצאה Necrotizing granulomatous vasculitis. בבדיקות הדם: נויטרופניה 1,500 בממ"ק, ANA בטיטר 160:1, cANCA ו- pANCA חיוביים. תפקודי הכליות ובדיקת השתן תקינים. מה השלב הבא בבירור?

א. ברונכוסקופיה
ב. בדיקת קריוגלובולינים
ג. שתן לטוקסיקולוגיה
ד. בדיקת כיח לשחפת

88. בן 68, עם שחמת על רקע הפטיטיס B, שאושפז עקב החמרה במיימת, כאב בטן וחום. בניקור המיימת נמצאו 3,000 תאים, מהם 50% נויטרופילים. מה נכון לגבי מצבו של החולה?

א. Serum Ascites Albumin Gradient (SAAG) קטן מ- 1.1 שולל זיהום
ב. החיידקים השכיחים שגורמים למצב זה הם *E. coli* ושאר חיידקי מעי
ג. הגדרת זיהום שיש לטפל בו מחייבת לפחות 1,000 נויטרופילים במיימת
ד. בחולים עם דליות, מצב זה הוא בשכיחות נמוכה יותר באופן משמעותי

89. בת 55 מתלוננת על חולשה וגרד. במעבדה: ALT 50, AST 55, ALP 325, γGT 470, Bilirubin 1.4, CRP, שקיעת דם ורמת IgG תקינים. מה נכון לגבי אבחון מחלתה?

א. העדר Anti Mitochondrial Ab **לא** שולל את אבחנת מחלתה
ב. יש לאשר את אבחנת מחלתה באמצעות בדיקת ERCP
ג. יש לאשר את אבחנת מחלתה באמצעות בדיקת EUS
ד. המחלה מאובחנת באמצעות בדיקת PET-CT

90. בן 42, מאושפז עקב שלשול מימי וחום, ומטופל בנוזלים. בתרבית צואה צמיחה של *Shigella*. מה הגישה לטיפול אנטיביוטי?

א. ללא מחלות רקע אין צורך בד"כ בטיפול אנטיביוטי
ב. טיפול הבחירה המקובל היום הוא Doxycycline
ג. טיפול הבחירה המקובל היום הוא Trimethoprim-Sulfamethoxazole
ד. טיפול הבחירה המקובל היום הוא Metronidazole

91. מה טיפול הבחירה המיידי בחולה עם תרשים אק"ג **שבתמונה 18**?

א. Amiodarone
ב. Lidocaine
ג. Procainamide
ד. Verapamil

92. מה נכון לגבי הטיפול ברפרוף עליות (Atrial flutter)?

א. מתן Adenosine גורם להפסקת הפרעת הקצב באופן מיידי
ב. מתן Amiodarone ימנע כ- 70% מהתקפים חוזרים לתקופה ממושכת
ג. אבלציה של ה- Cavo-tricuspid isthmus יעילה ב- 90% מהמקרים
ד. מתן Amiodarone מונע את הצורך בטיפול אנטיקואגולנטי

93. בת 32, בהריון בשבוע 20, מתלוננת על חולשה, צימאון והשתנה מרובה. בדיקת גלוקוז בצום - 130 מ"ג/ד"ל, כשהבדיקה בצום לפני ההיריון הייתה 90 מ"ג/ד"ל. מה יש להסביר לה?

א. שיש לה סיכוי עד 60% לפתח סוכרת כ- 10-20 שנה אחרי הלידה
ב. שרמת הסוכר שלה תקינה להריון
ג. שרוב הסיכוי כי תמשיך להיות סוכרתית אחרי הלידה
ד. שמומלץ מעקב להתפתחות סוכרת אחת לשנה

94. בן 62 בריא בד"כ. מאושפז בשל מחלת חום עד 39, שיעול ושלשול מזה מספר ימים. בשל בדיקת מעבדה של 35,000 תרומבוציטים בממ"ק נשלח למיון. בבדיקה החולה נינוח, יציב המודינמית וללא סימני פורפורה. במעבדה המוגלובין 14.2 גר'/ד"ל, תרומבוציטים 32,000/ממ"ק, לויקוציטים 12,000/ממ"ק, קריאטינין 0.6 מ"ג/ד"ל LDH ובילירובין תקינים. משטח הדם **בתמונה 19**. מה הצעד הבא בניהול החולה?

א. לקחת תפקודי קרישה
ב. לקחת בדיקה לרמת ADAMTS13
ג. לקחת נוגדנים ל- HIT
ד. לחזור על הספירה במבחנת ציטרט

95. בת 85 של״ד נמדד בממוצע 190/65 ממ״כ, מה ירמוז שמדובר ב- Pseudohypertension?

א. באקו-לב מודגם אי ספיקת המסתם האאורטלי בחומרה קשה
ב. לאחרונה הותקנה פיסטולה ברכיו-צפאלית לצורך דיאליזה
ג. דופק רדיאלי נמוש למרות חסימת העורק הברכיאלי בזמן מדידת ל״ד
ד. באקו-לב מודגמת חסימה דינמית במוצא החדר השמאלי (HOCM)

96. על מה יש להקפיד לפני לקיחת בירור להיפראלדוסטרוניזם כסיבה ליתר ל״ד שניוני?

א. הפסקת טיפול במעכבי ACE למשך שבועיים
ב. הפסקת טיפול במשתנים למשך שבועיים
ג. מתן עירוי 0.9% Saline יממה קודם
ד. תיקון היפוקלמיה לפני לקיחת רמת אלדוסטרון

97. איזו תרופה מהבאות עלולה לגרום להיפוקלמיה?

א. Trimethoprim
ב. Heparin
ג. Thiamine
ד. Pseudoepherdrine

98. בת 72 הסובלת מ- COPD קשה, מתאשפזת בפעם השלישית השנה עם החמרה במצבה. למרות הטיפול במיון מציינת שמצבה מחמיר ושהיא מתעייפת. בבדיקתה: ישנונית, לחץ דם 150/90 ממ״כ, דופק 95 לדקה, סטורציה 95% עם משקפי חמצן, 38 נשימות לדקה תוך שימוש בשרירי עזר. האזנה לריאות קשה בגלל חוסר שיתוף פעולה. גזים בדם עורקי: pH 7.25, pCO_2 70, pO_2 75, HCO_3 28. מה התמיכה הנשימתית המועדפת במקרה זה?

א. הנשמה לא פולשנית
ב. High flow O_2 therapy
ג. הנשמה פולשנית
ד. חמצן ואינהלציות

99. בן 40, שלפני כחודש טופל בשל דלקת בחניכיים ב- Amoxycillin-Clavulonate ופיתח פריחה מגרדת. כעת פונה עקב שיעול ליחתי, קוצר נשימה וחום. בצילום תסנין בריאה ימנית. מה הטיפול בו כעת?

א. Azithromycin
ב. Doxycycline
ג. Levofloxacin
ד. Cefuroxime

100. מה מהווה התווית נגד מוחלטת להשתלת כבד בבן 68, עם שחמת אלכוהולית?

א. אי ספיקת לב עם EF 25%
ב. הפטומה בגודל 1.5 ס״מ
ג. נשא HIV עם CD4 פחות מ- 100/µL
ד. גילו של החולה

101. מה נכון לגבי עמידות לאנטיביוטיקה ב- *S. pneumoniae*?

א. גיל מעל 65 שנים הוא גורם סיכון לעמידות ל- Penicillin
ב. ניתן להשתמש ב- Macrolids כקו ראשון כי העמידות לתרופות נדירה
ג. עמידות ל- Quinolons קשורה לאלרגיה ל- Penicillin
ד. **<u>אין</u>** קשר בין עמידות ל- Penicillin לעמידות לאנטיביוטיקה אחרת

102. מה נכון לגבי יעילות הטיפול באבלציה של ורידי הריאה בטיפול בפרפור עליות?

א. טיפולי אבלציה חוזרים **<u>לא</u>** משפרים את סיכויי השמירה על קצב סינוס
ב. יעילות האבלציה כטיפול לפרפור עליות התקפי פחותה מהיעילות בפרפור כרוני
ג. הטיפול באבלציה פחות יעיל בחולים עם מחלת לב משמעותית
ד. אבלציה מפחיתה את התגובתיות לטיפול תרופתי אנטי אריתמי

103. בת 40 עם עליה משמעותית ב- AST ו- ALT, גלובולין מוגבר ובדיקות ל- HBV ו- HCV שליליות, עוברת ביופסיית כבד שמראה Interface hepatitis וריבוי תאי פלסמה. מה הטיפול הראשוני בחולה?

א. Azathioprine 50 mg/d
ב. Cyclosporine 200 mg/d
ג. Prednisone 60 mg/d

ד. Rituximab 375 mg/m^2

104. בן 80, סיעודי, מתקבל עקב חום עד 38.5, כאבי ראש, וחולשה קלה בפלג גוף ימין. לא ידוע על חבלת ראש או ניתוח נוירוכירורגי, ולא היה מאושפז לאחרונה. ב- CT מוח חשד למורסה (Abscess) בהמיספרה השמאלית. בנוסף לניקוז, מה טיפול הבחירה האנטיביוטי?

א. Vancomycin
ב. Meropenem
ג. Ciprofloxacin + Clindamycin
ד. Ceftriaxone + Metronidazole

105. מה נכון לגבי TAVR כטיפול להיצרות משמעותית של המסתם האאורטלי?

א. מיועד רק לחולים בסיכון גבוה לניתוח של החלפת מסתם כירורגית
ב. טיפול תרופתי מיטבי יעיל כמו TAVR בחולים סימפטומטים
ג. אירוע מוחי בעבר מהווה התווית נגד ל- TAVR
ד. כ- 10% מהחולים שעוברים TAVR יזדקקו לקוצב לב בעקבות הפרוצדורה

106. בן 55, מבצע פעילות גופנית של הליכה כחצי שעה כל יום, אובחן כסובל מסוכרת ומטופל ב- Metformin. לאיזה ערכי גלוקוז עליו לשאוף?

	גלוקוז (מ״ג/ד״ל) לפני ארוחה	גלוקוז (מ״ג/ד״ל) שעתיים אחרי ארוחה
א	עד 140	עד 190
ב	עד 130	עד 180
ג	עד 126	עד 170
ד	עד 136	עד 180

107. בת 29 בריאה בד״כ, פונה בשל חולשה קיצונית ללא פרטים נוספים משמעותיים באנמנזה. במעבדה: תרומבוציטים 20,000 בממ״ק, המוגלובין 8 גר׳/ד״ל, לויקוציטים 12,000 בממ״ק, קריאטינין 1.7 מ״ג/ד״ל, LDH 600. משטח הדם **בתמונה 20**. מה ידוע על מחלתה?

א. במקרים של הישנות ניתן לשקול טיפול ב- Rituximab
ב. הבדיקה האבחנתית היא מדידת רמת von Willibrand Factor
ג. הצורה האידיופתית של המחלה אופיינית יותר בגברים
ד. הסיכון להישנות המחלה נמוך מעשרה אחוז

108. מטופל בדיאליזה פריטונאלית, מאושפז עקב כאבי בטן וחום. בדיקור הנוזל 200 תאים מתוכם 120 PMN. מה יש לעשות כעת?

א. להוציא מיידית את קטטר הדיאליזה
ב. להתחיל באנטיביוטיקה לתוך הפריטונאום
ג. לבצע בדחיפות CT בטן לשלילת פרפורציה
ד. לחפש מקור אחר לחום

109. בת 88, הובאה למיון בהכרה מעורפלת ומתנשמת. בבדיקתה: סטורציה 95% באוויר חדר, ל"ד 150/85 ממ"כ, דופק 120 סדיר. ללא חום. במעבדה: המוגלובין 14 מ"ג/ד"ל, ללא לויקוציטוזיס, תרומבוציטים 86,000 בממ"ק, אוראה 220 מ"ג/ד"ל, קריאטנין 2.5 מ"ג/ד"ל, גלוקוז 120 מ"ג/ד"ל, נתרן 110 מא"ק/ל, אשלגן 5.5 מא"ק/ל, סידן 13.5 מ"ג/ד"ל, חלבון 10.5 ג'/ד"ל, אלבומין 3 ג'/ד"ל, אוסמולליות בדם 278 מאוסמ/ל. מה הטיפול בשלב הזה?

א. 150 מ"ל של עירוי Saline 3%
ב. 2,000 מ"ל של עירוי Saline 0.9%
ג. 2,000 מ"ל של עירוי Ringer lactate
ד. Furosemide 40 mg תוך-ורידי + Saline 0.9% 2,000

110. בן 77 שמאובחן עם Idiopathic pulmonary fibrosis. מה ניתן לומר לו על הטיפול במחלה זו?

א. אין טיפול יעיל אבל רצוי להיות במעקב ולהצטרף ניסויים קליניים
ב. יש היום טיפולים יעילים כגון Mycophenolate mofetil
ג. טיפול ב- Nintendanib מעכב את התדרדרות המחלה
ד. טיפול בסטרואידים יחד עם Rituximab משפר חלק גדול מהחולים

111. בת 50 סובלת מחום חולשה ושיעול. בבדיקה - פריחה פורפורית מורמת, חולשה באצבעות יד ימין ו- drop foot משמאל. בבדיקות הדם: לויקוציטים 10,000 בממ"ק, מהם 3,000 אאוזינופילים, pANCA חיובי חזק. מה טיפול הבחירה בחולה זו?

א. Mepolizumab
ב. Prednisone + Cyclophosphamide
ג. Rituximab
ד. Azathioprine + Methotrexate

112. מתי יש צורך בביצוע ביופסיית כבד?

א. עלייה מתמשכת, לא ברורה באנזימים ההפטוצלולריים
ב. לפני החלטה על הפסקת טיפול ב- Autoimmune hepatitis
ג. כשיש כבד מצומק מסיבה לא ברורה
ד. לפני החלטה על מתן טיפול ב- Direct Anti-Virals ל- Hepatitis C

113. מה נכון לגבי פגיעה טוקסית בכבד של Amoxycillin-Clavulonate?

א. הפגיעה האופיינית היא עלייה בטרנסאמינזות
ב. זו התרופה הנפוצה ביותר שגורמת לפגיעה טוקסית בכבד
ג. לרוב יש פריחה נילווית לפגיעה הטוקסית בכבד
ד. הפגיעה האופיינית מתחילה מיד עם נטילת התרופה

114. בן 30, בריא, נפגע בתאונת דרכים ומאושפז ביחידת טיפול נמרץ כללי כשהוא מונשם ומורדם. כעבור 3 ימים הוא מפתח חום, הפרשות מוגלתיות מהטובוס ובצילום חזה תסנין בריאה הימנית. מה הטיפול האנטיביוטי הנכון?

א. Ceftriaxone
ב. Ertapenem
ג. Vancomycin
ד. Linezolid

115. בן 75 עם שלשול וטוקסין ל- *C. difficile* חיובי החל טיפול ב- Metronidazole פומי עם תגובה טובה והיעלמות השלשול לאחר 7 ימי טיפול. מה נכון לגבי מצבו?

א. אין מקום להמשיך טיפול מעל 7 ימים
ב. ניתן להפסיק טיפול במידה ותבחין צואה לטוקסין ואנטיגן שלילי
ג. Metronidazole מומלץ רק בהעדר Vancomycin או Fidaxomicin
ד. הסיכון להישנות הוא כ- 50%

116. מה מוצאים כשמשווים את **כל** התרופות בקבוצת Direct Oral Anti-Coagulants (Doac's) ל- Warfarin?

א. DOAC's יעילים יותר באופן משמעותי במניעת שבץ לעומת Warfarin
ב. DOAC's בטוחים יותר מבחינת דימומים מוחיים לעומת Warfarin
ג. DOAC's בטוחים יותר מבחינת דימומים במערכת העיכול מ- Warfarin
ד. DOAC's בטוחים יותר בחולים עם אי ספיקת כליות לעומת Warfarin

117. בן 80 מגיע לחדר מיון בהכרה מעורפלת מסיבה לא ידועה. במסגרת בדיקות השגרה שנערכות מבוצע אק"ג (**תמונה 21**). מה יש לבצע במטופל זה כדי להגיע לאבחנה וטיפול?

א. מדידת חום
ב. בדיקת רמת אשלגן
ג. בדיקת רמת גלוקוז
ד. בדיקה אלקטרופיזיולוגית (EPS)

118. בת 20, מאושפזת בשל חום, שיעול, כאב בטן והקאה חוזרת. בבדיקתה חום 38.5, דופק 110 סדיר, לחץ דם 95/60 ממ"כ, חירחורים בבדיקת הריאות ורגישות קלה בבדיקת הבטן. במעבדה: המוגלובין 12.5 גר"/ד"ל, לויקוציטים 19,500 בממ"ק, גלוקוז 320 מ"ג/ד"ל, נתרן 135 מא"ק/ל, אשלגן 5.2 מא"ק/ל, כלור 110 מ"ג/ד"ל, קריאטינין 1 מ"ג/ד"ל, pH 7.1, ביקרבונט 9 מילימול/ל, pCO2 32 מ"מ כספית, ובשתן אין לויקוציטים, אריתרוציטים או ניטריטים. קטונים +3. מה הטיפול המומלץ?

א. IV Saline 0.45%, IV Bicarbonate, IV Insulin, PO Kayexalate
ב. IV Saline 0.9%, IV Bicarbonate, IV Insulin
ג. IV Saline 0.9%, IV Insulin, PO Kayexalate
ד. IV Saline 0.9%, IV Insulin

119. בן 67, לאחר החלפת מסתם מיטרלי ואאורטלי, מטופל ב- Warfarin. הגיע עקב ערפול הכרה. ב-CT מוח דימום תוך מוחי. בדיקת INR-2.9. מה טיפול הבחירה התוך-ורידי בחולה זה?

א. ויטמין K במינון 10 מ"ג
ב. ויטמין K במינון 10 מ"ג יחד עם Idarucizumab
ג. Prothrombin Complex Concentrate ו-ויטמין K 10 מ"ג
ד. Fresh Frozen Plasma ו-ויטמין K 10 מ"ג

120. לחולה שנותן 5.5 ליטר שתן לילה יש את הבדיקות הבאות: אוראה 180 מ"ג/ד"ל, קריאטנין 1.5 מ"ג/ד"ל, גלוקוז 150 מ"ג/ד"ל, נתרן 153 מ"ג/ד"ל, אשלגן 3.1 מ"ג/ד"ל. בשתן אוסמולליות 750 מאוסמ/ל, נתרן 20 מא"ק/ל, אשלגן 15 מא"ק/ל. מה ההסבר למצבו?

א. התחלת טיפול ב- Furosemide תוך-ורידי
ב. התחלת טיפול ב- Lithium
ג. התחלה של כלכלת זונדה

ד. אובחן לאחרונה כסובל מגידול ריאתי

121. בן 95, אושפז עם חום. במעבדה גלוקוז 550 מ"ג/ד"ל, נתרן 162 מא"ק/ל ואשלגן 5.4 מא"ק/ל. כעבור שעתיים בבדיקות חוזרות גלוקוז 150 מ"ג/ד"ל, נתרן 169 מא"ק/ל ואשלגן 3.4 מא"ק/ל. מה הסיבה **הסבירה ביותר** לשינוי בבדיקות?

א. מתן 1,000 מ"ל מים בזונדה
ב. מתן 1,000 מ"ל תמיסת Ringer Lactate
ג. התחלת טיפול ב- Insulin תוך-ורידי
ד. מתן 1,000 מ"ל Saline 0.9%

122. איזה מהמדדים בנוזל פלאורלי יכול לתת אבחנה חד משמעית של סיבת התפליט?

א. גלוקוז נמוך מ- 60 מ"ג/ד"ל
ב. יחס של 0.7 בין LDH בנוזל לזה שבדם
ג. ספירת לויקוציטים של 12,000/ממ"ק
ד. NT-proBNP 1800 פק"ג/מ"ל

123. מה מאפיין Scleroderma renal crisis?

א. מתפתח רק בשלב מאוחר של ה- Scleroderma (מעל 10 שנים)
ב. נדיר בחולים עם נוגדנים לצנטרומר (anti-Centromer)
ג. נדיר בחולים מטופלים ב- Prednisone (מעל 40 מ"ג ליום)
ד. לחץ דם גבוה מאפיין את כל החולים במצב זה

124. מה נכון לגבי הטיפול עם Direct Anti Virals (DAA) לזיהום ב- HCV?

א. חולים עם זיהום משולב ב- HCV/HIV מגיבים פחות טוב מחולים עם HCV בלבד
ב. שחמת כבד מתקדמת ובלתי-מפוצה (Decompensated) היא התווית נגד לטיפול
ג. בחולים עם זיהום משולב ב- HBV/HCV יש לעקוב אחר ריאקטיבציה של HBV
ד. הטיפול יעיל רק במקרים של Chronic hepatitis C

125. בן 50, בריא בדר"כ וללא טיפול תרופתי קבוע, מאושפז עקב סחרחורת ללא בחילה או כאב בטן או טיפול תרופתי קבוע. בבדיקת הדם נמצא עמילז מוגבר, כשגם בבדיקות בשנים האחרונות היו ערכים גבוהים של עמילז. מה נכון לגבי העמילז במצב זה?

א. רמת העמילז בשתן תהיה נמוכה או אפסית
ב. רמת עמילז גבוהה בדם, כמו בחולה זה, נמצאת ב- 10% מהאוכלוסייה
ג. רמת העמילז הגבוהה מחשידה לדלקת כרונית בלבלב
ד. רמת העמילז הגבוהה תלווה בעליה ב- ALT ו- AST

126. מה היתרון בטיפול ב- Fidaxomicin בחולים עם שלשול עקב *C. difficile*?

א. מביא לריפוי קליני מהיר יותר מאשר Vancomycin
ב. מוריד את שיעור הישנות המחלה
ג. אפשר לטפל במתן תוך ורידי
ד. אפשר לתת את התכשיר בחוקנים

127. איזו תרופה משמשת בשילוב עם Ampicillin כטיפול סינרגיסטי לזיהום ב- *Enterococci*?

א. Oxacillin
ב. Ceftriaxone
ג. Trimethoprin-Sulfamethoxazole
ד. Ceftazidime

128. בן 70 עם אי ספיקת לב סיסטולית בחומרה בינונית מטופל בחוסמי בטא, ARB ו- Spironolactone במינונים אופטימאליים. למרות הטיפול מצבו מדרדר והוא נזקק לאשפוזים חוזרים. מה הצעד הנכון בטיפול בחולה?

א. החלפת ARB לשילוב של ARB/Sacubitril
ב. הוספת מעכב רנין ישיר כמו Aliskiren
ג. הפסקת ה- Spironolactone
ד. הוספת ACE inhibitor

129. בת 70, סיעודית עם רקע של אסתמה ומחלת לב איסכמית לאחר ניתוח מעקפים ומספר צנתורים כולל הכנסת סטנטים מתקבלת עקב כאבים בחזה במנוחה. ערכי טרופונין תקינים בשתי בדיקות ותרשים האק"ג ללא שינוי מתרשימים קודמים. מה הבדיקה הנכונה להדגמת סיבה כלילית לתלונותיה?

א. מבחן מאמץ
ב. בדיקת Cardiac CT
ג. אקו לב עם Dobutamine
ד. מיפוי לב עם Dipyridamole

130. בן 30 עם סוכרת Type 1, שחווה מספר אירועי היפוגליקמיה ללא סימפטומים אדרנרגיים. רמת ה- HbA1C 5.9%. בנוסף להורדת מינון האינסולין, מה צריך להסביר לחולה על מצבו (Hypoglycemia unawareness)?

א. התופעה בלתי הפיכה והוא יהיה בלתי מודע להיפוגליקמיה בכל חייו
ב. התופעה תחלוף כעבור 6-12 חודשים לאחר הפחתה במינון האינסולין
ג. התופעה תחלוף לאחר 2-3 חודשים אם יעבור למשאבת באינסולין
ד. התופעה תחלוף לאחר 2-3 שבועות אם אירועי ההיפוגליקמיה ימנעו

131. בן 67, שמאושפז בשל זיהום בדרכי שתן עם אלח דם (Sepsis), מפתח דימום מצנתר השתן וממערכת העיכול. במעבדה PTT 82 שניות ופיברינוגן 70 מ״ג/ד״ל. מה הטיפול היעיל ביותר שיעלה את רמת הפיברינוגן בחולה?

א. Fresh Frozen Plasma
ב. Prothrombin Complex Concentrate
ג. Cryoprecipitate
ד. Activated Factor VII

132. במי תצפו למצוא היפונתרמיה 124 מא״ק/ל, עם אוסמולליות סרום 264 מאוסמ/ל, בשתן אוסמולליות 350 מאוסמ/ל ונתרן בשתן 15 מא״ק/ל?

א. חולה שמטופלת ב- Prednisone ואושפזה כעת בגלל משבר אדיסוני
ב. חולה שאושפזה בגלל Hyperglycemic-hyperosmolar state
ג. חולה שאושפז בשל חסימת מעיים, בסיסת מטבולית קשה והיפוקלמיה
ד. חולה עם CHF, שאושפז עם גודש משני להפסקת טיפול ב- Furosemide

133. מה הפרעת החומצה-בסיס הבאה: pH 7.39, PCO2 28, ביקרבונט 16.5, לקטט תקין, גלוקוז 285, נתרן 124, כלור 94, אלבומין 3.6?

א. בסיסת נשימתית + חמצת מטבולית Normal AG
ב. בסיסת נשימתית + בסיסת מטבולית
ג. חמצת נשימתית + חמצת מטבולית Normal AG + High AG
ד. בסיסת נשימתית + חמצת מטבולית Normal AG + high AG

134. בת 25, אסימפטומטית, עם Diffuse Large B Cell Lymphoma וקליטה דיפוזית ב- PET-CT מעל ומתחת לסרעפת וגם בכבד. מה הטיפול בחולה בשלב זה?

א. מעקב וטיפול תומך
ב. Anti-CD30
ג. R-CHOP
ד. השתלת מח עצם אלוגנאית

135. בת 80 פונה עם תפליט פלאורלי חוזר, כשברקע מחלת לב איסכמית ובאקו לב תפקוד ירוד של חדר שמאל עם אי ספיקה מיטראלית בינונית. בדיקור התפליט נמדדו המדדים הבאים: pH 7.4, Glucose 98 (בסרום 110), Total protein 2.1 (בסרום 5.5), LDH 230 (בסרום 320). איך יוגדר התפליט?

א. אקסודאט
ב. טראנסודאט
ג. תפליט משני לתסחיף
ד. תפליט משני לממאירות

136. בן 35, סובל מ- Ankylosing spondylitis ומטופל ב- Adalimumab עם שיפור ניכר. כעבור 4 חודשים מתפתחת Psoriasis. החלפת הטיפול ל- Etanercept לא מועילה וה- Psoriasis מערבת עור וקרקפת באופן נרחב. איזו תרופה תוכל לטפל בשתי המחלות באופן מיטבי?

א. Cetrolizumab
ב. Prednisone
ג. Secukinumab
ד. Tocilizumab

137. בת 30, בהריון, מאובחנת כסובל מ- Acute Q Fever. מה הטיפול **<u>הנכון ביותר</u>**?

א. Doxycycline
ב. Azythromycin
ג. Levofloxacin
ד. Trimethoprim-Sulfamethoxazole

138. בן 55, מתלונן על פריחה פורפורית על השוקיים ללא סימפטומים אחרים. במעבדה: ספירה הדם תקינה, טרנסאמינזות פי 2 מהנורמה, שקיעת הדם מוחשת, RF חיובי, ANA שלילי, C4 נמוך ו- C3 תקין. בשתן - פרוטאינוריה והמטוריה מיקרוסקופית. מה האבחנה **<u>הסבירה ביותר</u>**?

א. Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
ב. Cryoglobulinemia
ג. Microscopic Polyangiitis (MPA)
ד. Henoch-Schonlein Disease

139. בת 50 התקבלה עם כאב בחזה. באקו לב נוזל פריקרדיאלי בכמות בינונית. מדדי הדלקת מוגברים, טרופונין שלילי. מה נכון לגבי הטיפול בחולה?

א. Anakinra מומלצת כטיפול קו שני
ב. סטרואידים מומלצים כקו ראשון
ג. Colchicine מומלץ במקביל ל- NSAID's
ד. Aspirin מומלץ במקביל ל- NSAID's

140. בן 60, סובל בשנה האחרונה מחולשה גוברת עד כדי חוסר יכולת לקום מהמיטה. בנוסף, מתלונן על אובדן שליטה על הסוגרים, ראייה כפולה והפרעות במצב הרוח. במעבדה: סידן 8.5 (תקין 8.5-10.5) וזרחן 1 (תקין 2.5-4.5). בדיקת CT כלל גופי הדגימה אוסטאופניה ניכרת וגוש בגודל 3x3 ס"מ מאחורי ההומרוס מימין. מה ימצא בבדיקות המעבדה?

א. ירידה ברמות 25-OH Vitamin D
ב. ירידה ברמות 1,25-OH Vitamin D
ג. ירידה ברמות FGF23
ד. עליה ברמות IGF2

141. בן 40, חסר בית ואלכוהוליסט ידוע. פונה למיון מעורפל הכרה, אגיטטיבי, מתנשם. בבדיקות המעבדה: pH 7.11, PCO2 25, ביקרבונט 8, נתרן 138, אשלגן 3.5, כלור 105, גלוקוז 65, לקטט גבוה, אוריאה 40, קריאטינין 0.9, אוסמולליות הסרום 320, בטא-הידרוקסיבוטירט בסרום - שלילי. מה האבחנה הסבירה?

א. הרעלת Isopropyl alcohol

ב. הרעלת Paracetamol
ג. הרעלת Ethylene glycol
ד. Alcoholic ketoacidosis

142. לחולה שאושפז עם תוצאות בדיקות שמראות סידן 7.2 מ״ג/ד״ל, זרחן 5.6 מ״ג/ד״ל, אוראה 120 מ״ג/ד״ל, קריאטינין 2.5 מ״ג/ד״ל, מה הבדיקה הבאה שיש לקחת לבירור ההיפוקלצמיה?

א. PTH
ב. 1,25(OH)2-vitD
ג. מגנזיום
ד. אלבומין

143. בת 40 פונה בשל עייפות חדשה, כאב בעכוז ימין, דלקת בלחמיות, חום, ארתריטיס בברך ימין וקרסול שמאל וכן דלקת במפרקים אינטרפלנגיאלים ברגלים. בכל פעם מצטרף מפרק נוסף. הבוהן ברגל נראית **בתמונה 22**. מה האבחנה **הסבירה ביותר**?

א. Systemic lupus erythematosus
ב. Psoriatic arthritis
ג. Reactive arthritis
ד. Gonococcal arthritis

144. בן 74, מתלונן על חולשה. בבדיקתו חיוור, ללא הגדלת קשריות לימפה, נמוש טחול 4 ס״מ מתחת לקשת הצלעות. במעבדה: המוגלובין 8.7 גר׳/ד״ל, שאר הספירה תקינה. בכימיה היפרגלובולינמיה. בפרוטאין אלקטרופורזיס נוכחות מקטע מנונוקלונלי של 3 גר׳/ד״ל מסוג IgM. CT בטן הדגים הגדלת כבד וטחול וקשריות לימפה עד 2 ס״מ באזור פארא-אאורטלי. מה בדיקת הבחירה לאבחון החולה?

א. ביופסית מח עצם
ב. FNA מבלוטה פארא-אאורטלית מונחית CT
ג. בדיקת PET-CT
ד. Low Dose CT מכוון לעצמות

145. בת 29 פונה למיון עקב כאבים בחזה וקוצר נשימה. בחשד לתסחיף ריאתי, במיוחד לאור d-dimer גבוה, הוצע למטופלת CTA של עורקי הריאה אבל עקב אלרגיה לחומר הניגוד, המטופלת מעדיפה לבצע מיפוי ריאות ventilation perfusion. מה נכון לומר לגבי בדיקה זו לאבחנת תסחיף ריאתי חד?

א. תשובת מיפוי תקינה משאירה כ- 40% סיכוי לתסחיף
ב. בתשובת מיפוי של סבירות גבוהה, יש תסחיף בכ- 90%

ג. לרוב ניתן לקבל תשובה ברורה מתוצאות המיפוי
ד. ברוב הנבדקים עם תסחיף תהיה סבירות גבוהה במיפוי

146. בן 50 סובל מחום כאב בטן וירידה במשקל. בבדיקה צהבת בלחמיות, וב- CT גוש בלבלב. בביופסיה מהגוש נמצא תסנין לימפו-פלסמוציטרי עם אאוזינופילים. איזו צביעה יש לבצע כדי להגיע לאבחנה סופית?

א. לתאי CD4 ציטוטוקסים
ב. ל- CD19
ג. ל- CA19-9
ד. ל- IgG4

147. לחולה שמאושפז בשל אי ספיקת כליות כרונית (eGFR-12 mL/min), שעדיין לא התחיל דיאליזה ומטופל בכדורי Calcium Sandoz, חוזרות תוצאות בדיקות: זרחן 6.5 מ"ג/ד"ל, סידן 8.5 מ"ג/ד"ל, אלבומין 3.6 ג/ד"ל. מה הטיפול בשלב ראשון בהפרעות בחולה?

א. Alpha-calcitriol (alpha-D3)
ב. Cinacalcet
ג. Kayexalate
ד. Sevelamer

148. מה עלול לגרום להתפתחות הממצא **בתמונה 23**?

א. Hypothyroidism
ב. טיפול ב- Peritoneal dialysis
ג. טיפול ב- Prednisone
ד. Endocarditis

149. בת 45, מטופלת בחודשים האחרונים ב- Cisplatin לסרטן הרחם וכעת מאושפזת בשל חולשת שרירים קשה וסחרחורת. בבדיקתה: אטקסיה ורעד בידיים. במעבדה מגנזיום 0.7 מ"ג/ד"ל, סידן 6.9 מ"ג/ד"ל, זרחן 1.1 מ"ג/ד"ל, אלבומין 3.3 ג/ד"ל. לאחר מתן עירוי מגנזיום מתלוננת על כאבי שרירים והחמרה בחולשה ובמעבדה נמצאת עליה ב- CPK מתקין ל- 1500. מה הסיבה למצבה?

א. החמרה של היפופוספטמיה
ב. החמרה של היפומגנזמיה
ג. התפתחות היפרקלצמיה

ד. החמרה של היפוקלמיה

150. מה נכון לגבי הטיפול ב- IBD?

א. Vedolizumab מיועד רק לחולי Crohn's **ולא** לחולי UC
ב. Vedolizumab **לא** גורם לדיכוי חיסוני סיסטמי
ג. עליית נוגדנים ל- Infliximab **לא** משפיעה על התגובה לטיפול
ד. Adalimumab **לא** גורם להתפתחות נוגדנים כנגדו